Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Reestruturação e Qualificação da Rede Hospitalar e de Atenção Especializada da Cidade de São Paulo - Avança Saúde II

Nº Carta Consulta: 60999
Mutuário: Município de São Paulo - SP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 160.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 250.600.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 13
3. FINANCIAMENTO 13
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 13
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 13
4. EXECUÇÃO 13
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 13
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 13
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 13
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 13
5. RISCOS 15
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 15
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 15
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 15
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 15
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 15
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 16
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 16

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

O Município de São Paulo (MSP), capital do estado de mesmo nome, é a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano e de todo o hemisfério sul, com população projetada para 2020 de 11.869.660 habitantes (SEADE, 2020) e densidade demográfica de 7.803 hab/km2.

A pirâmide populacional do MSP (Gráfico 1 - Anexo 1) demonstra a concentração de adultos na faixa etária entre 20 e 59 anos de idade, já as pessoas com mais de 60 anos de idade já representam 15,6% da população (SEADE, 2020). Tal processo de envelhecimento populacional impacta diretamente na definição da agenda de políticas públicas no setor saúde, amplia a demanda por ações de cuidado relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), agravadas pelas comorbidades.

Em termos gerais, a redução da natalidade acompanhada da diminuição nas taxas de mortalidade vem gerando um envelhecimento populacional crescente no MSP.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

O Município de São Paulo apresenta algumas das características típicas de uma metrópole: alta densidade populacional, enormes desigualdades intrarregionais e envelhecimento crescente.

Administrativamente, o MSP é dividido em seis regiões de saúde marcadamente desiguais: Centro, Leste, Norte, Oeste, Sudeste e Sul. As diferenças epidemiológicas são marcantes entre as regiões, a expectativa de vida ao nascer, por exemplo, difere substancialmente entre os bairros da cidade. No Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, a expectativa de vida ao nascer é de 85,33 anos. Já em São Miguel Paulista, na Zona Leste, esse valor cai para 71,28 anos (SMDHC, 2020).

O perfil de morbimortalidade de São Paulo também reflete as fortes disparidades socioeconômicas e históricas entre as regiões. Enquanto em algumas áreas da cidade as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as condições de saúde prevalentes, em outras ainda persiste um quadro de doenças infecciosas e mortalidade materno-infantil que revela defasagens comuns em países em desenvolvimento. Por exemplo, a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório chega a 27,78 em Campo Belo -região sul de SP- enquanto é 9, 34 em Anhanguera -região norte. Ao contrário, a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é de 8,24 em Campo Belo e 15,14 em Anhanguera (2015, SINASC/SMS).

As Tabelas 1 (Anexo 2) mostram as internações hospitalares ocorridas em estabelecimentos de saúde da Rede SUS sob gestão municipal (SMS) e estadual (SES), em 2021, segundo diagnóstico principal (Capítulo da CID 10). Observa-se o impacto da COVID que ampliou significativamente as internações relacionadas ao diagnóstico "algumas doenças infecciosas e parasitárias", porém ainda há predominância de internações relacionadas às DCNT.

Em relação ao perfil de mortalidade, são apresentados na Tabela 2 (Anexo 3) os coeficientes de mortalidade infantil e geral em 2021, além de taxas específicas. Observa-se que coeficiente de mortalidade infantil (CMI) vem mantendo tendência de queda nas duas últimas décadas no MSP, atingindo 10,3 óbitos/1.000 nascidos vivos em 2021.

REDE FÍSICA

A municipalidade possui uma rede de saúde complexa, potente e densidades tecnológicas diversificadas. Por outro lado, evidencia-se a presença significante do setor suplementar de saúde, girando em torno de 35% de beneficiários. O município conta com 72,7% da população coberta pela Atenção Primária (APS) à Saúde e 46,7% da população residente em área de atuação da Estratégia Saúde da Família (ESF). Reforça que um dos grandes desafios é consolidar a ESF como porta de entrada para o sistema, com metas para ampliar a cobertura no município.

No que diz respeito ao setor público, a cidade produz o maior número de procedimentos ambulatoriais de baixa, média e alta complexidades, assim como o maior número de internações SUS do país. Apresenta 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 24 hospitais gerais ou especializados que fazem parte de uma rede com 1.012 estabelecimentos / serviços de saúde sob gestão municipal, como detalhado na Tabela 3 (Anexo 4).

Na rede municipal os hospitais-dia atendem as cirurgias eletivas mais simples e as Unidade de Pronto Atendimento (UPA) as urgências mais simples, os hospitais municipais estão voltados para procedimentos urgentes, não tendo capacidade de atender as cirurgias eletivas mais complexas. Desta forma, cirurgias que poderiam ser antecipadas, em um caso mais simples, passa a ser atendida apenas quando o caso se agrava.

Não há diferenciação da rede hospitalar em hospitais estruturantes, estratégicos e de apoio, de acordo com os níveis de complexidade, levando, em muitos casos, à ocupação de leitos de alta complexidade com perfis patológicos não correspondentes a essa densidade tecnológica.

Os hospitais municipais são antigos, necessitando de investimentos para adequação às normas sanitárias (RDC Nº 51, DE 6 DE OUTUBRO DE 2011) e de mobilidade (ABNT-NBR-9050 de 2020), além de atualização/modernização de seus equipamentos.

IDH

O IDH 0,805 em 2010.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

No seu esforço em sanar as principais inadequações do sistema de saúde da cidade, a SMS/SP aponta diversas questões a serem enfrentadas e superadas, em consonância com as metas da Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar (Plano Municipal de Saúde 2022-225):

1. Planejar e executar as políticas e ações de saúde com foco nas linhas de cuidado, integrando os diferentes níveis de atenção, áreas técnicas e entes federativos;

2. Efetivação da reestruturação, com definição clara de atribuições, competências e responsabilidades que se reflitam em fluxos e processos de trabalho estabelecidos;

3. Política de informação e tecnologia da Secretaria para padronização de conceitos, fontes de dados, propriedade da informação e indicadores e seus usos.

O processo de planejamento e execução das políticas de saúde será mais efetiva quando (i) a reestruturação estiver consolidada; (ii) os sistemas de informação possibilitarem a troca de informações; (iii) a rede física existente estiver qualificada/modernizada e (iv) a equipe da SMS estiver qualificada para enfrentar os desafios que estão em constante transformação.

Neste sentido, em consonância com o Plano Municipal de Saúde 2022-2025, a requalificação física dos hospitais municipais é uma das prioridades e será apresentada no projeto como uma das propostas. Dos 24 hospitais municipais, há necessidade de intervenção em 13 hospitais para sua requalificação física. A viabilização da reforma estruturante seguirá diferentes estratégias:

a) Hospitais com projetos elaborados:

Os hospitais em situação mais críticas já tem seu projeto básico e orçamento em fase de revisão e serão licitados com recurso de contrapartida anteriormente à assinatura do contrato de empréstimo: Sorocabana, Hungria, Alípio Correa Netto, Waldomiro de Paula e Saboya.

b) Hospitais com projetos a serem contratados:

Serão contratados pelo Programa 5 reformas de hospitais municipais: Campo Limpo; Tatuapé, Ignacio Proença, Tide Setúbal e Cachoeirinha.

c) Hospitais com estudos para Parceria Público Privada (PPP):

Será contratada modelagem de PPP para 3 hospitais municipais e está previsto no Programa o recurso de CAPEX para reformar os hospitais: Alexandre Zaio, Mario Degni e Benedicto Montenegro.

Está prevista no Programa a aquisição de equipamentos para reposição e modernizar esses hospitais.

A reestruturação da Secretaria de Saúde foi iniciada com o decreto nº 59.685, de 13/08/20. Neste período foram reestabelecidos fluxos e processos de trabalho e redefinidas atribuições, competências e responsabilidades. O desafio neste momento é consolidar e aprimorar os processos por meio de certificação de qualidade dos hospitais e dos laboratórios municipais.

No Programa Avança Saúde (2019-2024) financiado pelo BID foi financiado o sistema de logística de suprimentos (medicamentos e insumos) dos estoques centralizados até as unidades de saúde. O próximo passo para gestão da logística de suprimentos é acompanhar e gerir o fluxo interno das unidades por meio de sistema informatizado de logística intra-hospitalar.

A gestão da rede de atenção à saúde na cidade, por meio da modernização e especialização dos serviços hospitalares, traz a necessidade de promover a capacitação dos gestores, como também da sua equipe técnica, nos diferentes níveis da organização técnico-administrativa dos hospitais e da SMS/SP, de forma a aumentar o potencial e habilidades de coordenação, planejamento estratégico, monitoramento e avaliação.

Nesse sentido, torna-se prioritário o investimento na melhoria estrutural (física e equipamentos) e qualificação tecno-assistencial dos pontos de atenção da hospitalar na cidade de São Paulo colocando a inovação em saúde como premissa para implementação de qualquer projeto.

RESULTADOS ESPERADOS

Dentre os resultados esperados, com relação a requalificação dos hospitais (obras, equipamentos, adequação estrutura física às normas sanitárias) espera-se a ampliação e modernização da quantidade de leitos, ambulatórios ou salas de procedimentos preparando a gestão municipal para atender a demanda epidemiológica atual e sua integração com a rede existente.

A Parceria Público Privado, além dos benefícios acima trará agilidade no processo de construção com possibilidade de redução do custo total ao longo da vida do ativo. Há de destacar as possibilidades de soluções inovadoras pelo ator privado, a otimização dos serviços com a partilha dos riscos entre setor privado e público.

Com relação a certificação de qualidade espera-se melhorar a qualidade da assistência prestada aos usuários do sistema de saúde, garantindo maior segurança para pacientes e profissionais de saúde tornando os processos de trabalho mais eficientes com melhor integração entre setores.

O sistema informatizado de gestão de suprimentos intra-hospitalar deverá gerar padronização e ganho de eficiência no fluxo de distribuição de insumos no hospital, redução de custos e aumento da segurança do paciente.

A capacitação da equipe da SMS-SP aperfeiçoará os processos de trabalho dos profissionais que atuam no SUS com ações de Educação Permanente, visando contribuir com a melhoria da qualidade da atenção à saúde dos usuários, alcançando melhores resultados de saúde e maior satisfação dos pacientes.

Resultado geral: Ampliar oferta e a qualidade do serviço hospitalar, com atendimento mais adequado às condições epidemiológicas e à rede de atenção municipal. Em termos de resultado destaca-se a melhoria da experiência do paciente, a adequação/otimização dos custos e o aumento da qualidade assistencial.

SUSTENTABILIDADE

Vale destacar que a requalificação dos hospitais, não trará significativa ampliação dos custos de operação. Haverá uma ampliação dos serviços prestados por estes hospitais, que resultará em ampliação dos gastos com material de consumo, porém o custo de pessoal será suprido com realocação da equipe dos 3 hospitais objeto de PPP.

Portanto, o custo significativo para sustentabilidade financeira das ações do Programa se refere à remuneração dos gastos operacionais dos 3 hospitais, que deverá gerar economia em relação à operação atual ao otimizar os gastos com serviços de "bata cinza".

Em termos de sustentabilidade vale destacar que a requalificação dos hospitais, dentre outros benefícios irá promover eficiência energética, redução de custos e sustentabilidades para os hospitais beneficiados. Em consonância coam o Manual de Sustentabilidade para Edificações Públicas, da Secretaria Municipal de Serviços e Obras do Município de São Paulo (Anexo 05) que define as diretrizes e os parâmetros sustentáveis.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Como orientação estratégica prioritária, vale destacar as diretrizes e metas apresentadas no Plano Municipal de Saúde 2022-2025. O Avança Saúde II visa contribuir para alcance das metas e objetivos detalhadas no plano, visando garantir a atenção integral à saúde da população e o aprimoramento do acesso à saúde com fortalecimento das redes de atenção à saúde. Principalmente nas diretrizes relacionadas ao aumento a melhora da capacidade de gestão da SMS-SP; a reorganização dos serviços em redes de saúde integradas, com compartilhamento do cuidado entre os níveis de atenção; a organização da rede hospitalar, considerando as necessidades territoriais e a economia de escala; a integração e expansão dos sistemas de informação em saúde - melhorando a gestão clínica e gerencial, otimizando recursos e ampliando a qualidade dos dados.

No Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, a principal ação vinculada ao Programa em pleito está a ação 3026 - AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE EM ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Considerando a Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, essa ação está vinculado ao Objetivo 3/Meta 3.8: Atingir a cobertura universal de saúde, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes e de qualidade. O PPA prevê recursos para implantação de novos equipamentos e também para reforma, conforme sinalizado no recurso de contrapartida previsto no projeto.

O sistema previsto no Programa está vinculado à ação 3011 - MODERNIZAÇÃO, DESBUROCRATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERVIÇO PÚBLICO e a capacitação está vinculada à ação 3024 - SUPORTE ADMINISTRATIVO.

Na Agenda 2030 (ONU), essas ações estão vinculadas aos objetivos e metas detalhadas abaixo:

-Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

--Meta 12.7. Promover práticas de contratações e gestão pública com base em critérios de sustentabilidade, de acordo com as políticas e prioridades municipais.

-Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

--Meta 16.6. Ampliar a transparência, a prestação de contas, a efetividade e a eficiência das instituições, em todos os níveis.

-Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

--Meta 17.17. Incentivar e promover parcerias eficazes nos âmbitos públicos, público-privados, privados e da sociedade civil, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

CONTRAPARTIDA

A contrapartida para o Programa será proveniente de receitas tributárias do município. Já há recurso disponível para contratação de obras de reforma para 6 hospitais que serão realizadas integralmente com recurso de contrapartida.

TAXA DE CÂMBIO

R$ 5,0589 (24/04/23)

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Reestruturação e Qualificação da Rede Hospitalar e de Atenção Especializada da Cidade de São Paulo - Avança Saúde II

2.2. Título Abreviado
Avança Saúde II

2.3. Mutuário
Município de São Paulo - SP

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

O objetivo do Programa é contribuir para a melhorar as condições de saúde da população do Município de São Paulo, por meio da ampliação do acesso, da qualidade dos serviços ofertados, da garantia de segurança do paciente e da melhoria do desempenho dos processos da rede hospitalar municipal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A.Modernizar e Ampliar a Infraestrutura da Rede Hospitalar.

B.Melhorar a Eficiência e a Qualidade da Rede Hospitalar

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de cirurgia eletivas por mês	Numerador: Contagem absoluta de AIH, com procedimento realizado do grupo 04. xx.xx.xxx-xx, excetuando os procedimentos obstétricos (04.11.xx. xxx-xx) | Denominador : número de meses considerados | * Hospitais considerados: 13 Hospitais do Programa	cirurgias/mês	789,50	950,00
Tempo médio de Internação	Numerador: soma de Dias de Perm de todas as AIH do período considerado | Denominador: contagem de AIH no período considerado (todas as AIH) | * Hospitais considerados: 13 Hospitais do Programa	dias/AIH	6,18	4,50
Percentual de hospitais e laboratórios com certificação hospitalar	Numerador: Número de hospitais e laboratórios certificados no âmbito do programa financiado com recursos de empréstimo | Denominador: Número de hospitais e laboratórios existentes	percentual	0,00	100,00
Taxa de Mortalidade Institucional	Numerador: contagem de AIH com motivo de cobrança óbito | Denominador: contagem de AIH (todas as formas de saída no período considerado) | * Hospitais considerados:13 Hospitais do Programa	percentual	5,50	4,00

Número cirurgias por sala cirúrgica por dia	Numerador: quantidade total de saidas de AIH com procedimento cirurgico (excetuando obstetrícia 04.11.xx. xxx-xx) realizadas no mês | Denominador: quantidade de salas cirurgicas-dia no mês (salas cirúrgicas CNES) | * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa | ** Salas consideradas: Sala de Cirurgia, Sala Cirurgia Ambulatorial	cirurgias/sala-dia	2,00	2,50
Número de saídas por mês	Numerador: contagem de saidas de AIH (todos os motivos) | Denominador: número de meses considerados | * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa	Saídas / mês	8.361,00	9.200,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	**299.280.000,00**
P - 1.1 Requalificação dos Hospitais	214.000.000,00
P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais	60.000.000,00
P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados	19.280.000,00
P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras	6.000.000,00
C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO	**102.820.000,00**
P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar	3.000.000,00
P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar	98.220.000,00
P - 2.3 Certificação da Qualidade	800.000,00
P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar	600.000,00
P - 2.5 Capacitação	200.000,00
C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	**8.500.000,00**
P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento	6.000.000,00
P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa	1.600.000,00
P - 3.3 Consultoria de Comunicação	300.000,00
P - 3.4 Avaliação do Programa	600.000,00
Total dos Componentes	**410.600.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

este componente tem por objetivo requalificar e ampliar as redes hospitalar do Município de São Paulo. Serão financiados, entre outros: projetos, obras civis, apoio a fiscalização das obras, equipamentos médicos e mobiliário.

P - 1.1 Requalificação dos Hospitais

Requalificação dos hospitais por meio de reformas de recuperação da estrutura civil, reforma de adequação às novas normativas sanitárias e acessibilidade e incêndio.

P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais

Requalificação dos hospitais por meio de Parceria Público Privada que possibilitará ofertar à população hospitais modernizados e focados no atendimento ao paciente

P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados

Compra de novos equipamentos médicos e mobiliários.

P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras

Apoio técnico à realização das obras incluindo elaboração de projetos e apoio a fiscalização das obras.

C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO
Este componente aumentará o desempenho da Rede Hospitalar da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mediante a ampliação de suas capacidades institucionais, estratégicas e gerenciais.

P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar
Modelagem para concessão por meio de PPP, contemplando avaliação da estrutura (engenharia), demandas e processos assistenciais, modelagem econômico-financeira e modelagem jurídica.

P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar
Implantação de sistema para informatizar a logística intra-hospitalar nos hospitais com administração direta da SMS-SP

P - 2.3 Certificação da Qualidade
Certificação de qualidade nos 24 hospitais municipais e 6 laboratórios.

P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar
Consultoria para apoio a certificação de qualidade em hospitais e laboratórios incluindo diagnóstico situacional, proposição de melhoria nos processos, acompanhamento da implementação dos novos processos e apoio às visitas de certificação.

P - 2.5 Capacitação
Capacitação de profissionais da rede hospitalar e laboratorial da SMS-SP

C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Este componente apoiará a SMS a executar o Projeto e dar andamento aos resultados previstos. Serão financiados, entre outros: (i) serviços de apoio à gestão do Projeto; (ii) serviços técnicos especializados; (iii) auditoria independente; e (iv) avaliações intermediária, final e de impacto do Projeto.

P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento
Consultoria de apoio ao gerenciamento do Programa.

P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa
Consultores individuais para atuarem como coordenadores setoriais, em suas áreas de especialidade, em apoio ao coordenador geral do Programa.

P - 3.3 Consultoria de Comunicação
Consultorias para apoiar a comunicação do programa: apresentações, press release, site institucional e livro síntese do Programa.

P - 3.4 Avaliação do Programa
Consultorias para avaliação do Programa: Auditoria financeira, Análise de Impacto e Avaliação Intermediaria e Final.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**214.000.000,00**	**52,12**
P- 1.1 Requalificação dos Hospitais	Número de hospitais	10,00	214.000.000,00	52,12
Bens	-	-	**79.280.000,00**	**19,31**
P- 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais	Número de hospitais	3,00	60.000.000,00	14,61
P- 1.3 Hospitais equipados e mobiliados	Número de hospitais	10,00	19.280.000,00	4,70
Consultoria	-	-	**18.100.000,00**	**4,41**
P- 1.4 Apoio técnico à realização das obras	Relatórios	48,00	6.000.000,00	1,46
P- 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar	No.hospitais modelados	3,00	3.000.000,00	0,73
P- 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar	Equip. saúde proc. aprim.	30,00	600.000,00	0,15
P- 3.1 Apoio ao Gerenciamento	Relatórios	48,00	6.000.000,00	1,46
P- 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa	Relatórios	48,00	1.600.000,00	0,39
P- 3.3 Consultoria de Comunicação	Relatórios	48,00	300.000,00	0,07
P- 3.4 Avaliação do Programa	Relatórios	8,00	600.000,00	0,15
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**99.020.000,00**	**24,12**
P- 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar	No Hospitais sistema impl	13,00	98.220.000,00	23,92
P- 2.3 Certificação da Qualidade	Equip. saúde certificados	30,00	800.000,00	0,19
Capacitação e Treinamento	-	-	**200.000,00**	**0,05**
P- 2.5 Capacitação	Profissionais capacitados	300,00	200.000,00	0,05
Total Geral	-	-	**410.600.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Dentre as etapas já realizadas e que possibilitam a qualificação e consolidação de um projeto que atua sobre os principais problemas de inovação tecnológica e acesso a serviços e exames especializados na saúde, ressaltamos que:

Em junho de 2019 foi firmado o Contrato de Empréstimo entre o município de São Paulo e o BID para o Programa Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo - Avança Saúde SP, com objetivo de melhorar acesso e qualidade dos serviços, tendo como foco a atenção primária e a rede de urgência e emergência, bem como o fortalecimento da gestão da informação com incentivo à inovação e uso de novas tecnologias em saúde. Com relação as obras e reformas previstas no Avança Saúde São Paulo I , temos 13 UPAs (8 obras novas e 5 reformas), 99 UBSs (11 obras novas e 88 reformas), 01 Centro de Cuidados Integrados reformado, além dos Hospitais de Brasilândia e dos equipamentos para o Hospital Parelheiros, e a reforma do Pronto Socorro do Hospital São Paulo. Já foram entregues para a sociedade: 06 UPAs novas e 2 reformas; 01 UBS nova e 84 reformas; todos os hospitais e pronto socorro em funcionamento.

No âmbito da saúde digital o Avança Saúde SP I, inovou ao desenvolver as bases para a implantação da telemedicina, do prontuário eletrônico e a integração dos dados clínicos. O e-saudesp, uma das entregas, funciona como plataforma de saúde disponível nas versões Web, Android e iOS. A Teletriagem @covid, foi essencial durante a pandemia, um canal de acolhimento aos pacientes com dúvidas ou sintomas da Covid-19, conforme o resultado, o paciente poderá ter acesso a teleconsulta com médicos e enfermeiros. O e-saudesp já registrou 15 milhões de acesso e mais de 1,5 milhões de atendimentos. O também foi destaque em evento realizado na Suiça .

Ainda no âmbito da tecnologia da informação em saúde outra entrega concluída foi o Gerenciamento Integrado de Classificação de Risco e Articulação da Rede, com 53 portas/serviços integradas gerando informações sobre tipo de atendimento e classificação de risco, bem como informações gerenciais sobre as unidades. Foram treinados 696 profissionais no protocolo Manchester.

Previsto para iniciar, ainda em 2023, o Selo de Qualidade ONA irá acreditar 340 UBS e contribuir para estruturar o Núcleo de Gestão da Qualidade na SMS-SP. Um passo importantíssimo para alcance da efetividade e qualidade da assistência, um dos compromissos da gestão municipal.

Outra grande inovação do Programa, que visa dar transparência e levar conhecimento para a população sobre as obras em andamento é o Sistema ObraGov . De forma simples e rápida, através de uma ferramenta de georeferenciamento é possível acessar informações detalhadas sobre as obras como período de execução, empresa contratada, prazos de execução, informações financeiras, identificação dos fiscais da obra, fotos.

Recentemente o Programa Avança Saúde SP I passou pela avaliação intermediária, recebendo classificação Satisfatória em todos os critérios analisados pelo BID em termos de relevância, eficácia e eficiência. Com boa execução física e financeira, considerando o período de inicio do Programa e a pandemia COVID-19, é visível que os indicadores de resultados estão caminhando na direção adequada, o que mostra o intento da equipe da UCP na execução do Programa.

Por fim, vale destacar o reconhecimento e resultados alcançados no Avança Saúde SP I, em especial o reconhecimento da população como demonstrado na Pesquisa realizada pelo Datafolha, que aponta que a rede municipal de saúde é um dos serviços mais bem avaliados pelos paulistanos; o resultado enalteceu os avanços na informatização da rede com foco na promoção de cuidado na Atenção Básica . Outros prêmios e reconhecimentos podem ser consultados

https://www.capital.sp.gov.br/noticia/aplicativo-e-saudesp-e-destaque-em-evento-na-suica#:~:text=O%20aplicativo%20e%2Dsa%C3%BAdeSP%2C%20da,cidade%20de%20Basil%C3%A9ia%2C%20na%20Su%C3%AD%C3%A7a.

Apesar dos avanços alcançados com o Programa Avança Saúde SP I, que ajudou o município no enfrentamento da pandemia, há no momento o desafio de fortalecer e qualificar os serviços hospitalares que enfrentam desafios, estruturais e de qualificação, para atender a demanda reprimida, situação agravada no pós-pandemia.

Assim sendo, é importante dar continuidade as ações do Avança Saúde I, para prosseguir nas mudanças necessárias que levem à conformação de um sistema integrado que opere de forma contínua e proativa e que seja capaz de responder, com eficiência, efetividade, qualidade e de modo equilibrado, às condições agudas e crônicas da população. Adequado para a atual situação epidemiológica e demográfica do município de São Paulo

Vale destacar que para o Avança Saúde SP II não há necessidade de licenciamento ambiental tendo em vistas as intervenções ocorrerão em áreas já ocupadas pelos hospitais e já foram realizados 5 projetos de engenharia que serão licitados em 2023.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SAO PAULO(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Devido às necessidades e desafios de saúde pública aqui apresentadas pelo município de São Paulo, a possibilidade financiamento externo pode permitir a manutenção e ampliação do acesso à saúde de qualidade, oferecendo inovação para o setor público.

Por outro lado, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) tem tradição em oferecer oportunidades de financiamento para países da América Latina e Caribe para melhoria da atenção à saúde das populações, o município de São Paulo oferece este pleito, como uma estratégia para a continuidade da melhoria do SUS no município.

O valor proposto do empréstimo é de $ 250.600.000,00 com contrapartida do município de $ 160.000.000,00

Este projeto seguirá os Termos e Condições Financeiras Aplicáveis aos Empréstimos de Investimento com Recursos do Capital Ordinário do BID (vide anexo), sendo:

-Carência: 5,5 anos (66 meses)

-Prazo de amortização: 25 anos (máximo)

-Vida Média Ponderada (VMP): 15,25 anos (máximo)

Período para amortização e Vida Média Ponderada (VMP): O vencimento de empréstimos de investimento é de no máximo 25 anos e a vida média ponderada máxima de no máximo 15,25 anos.

Períodos de Desembolso e Carência: Os empréstimos standard têm um cronograma de amortização linear, com prestações semestrais (ou trimestrais), consecutivas e na medida do possível iguais. Considerando que o período para desembolsos típico é de 5 anos contados da data de vigência do contrato de empréstimo, o período de carência típico é de 66 meses.

Taxas de juros: SOFR + 1,16% a.a. (2o trimestre 2023)

Credit Fee: até 0,75% sobre o saldo não desembolsado

Recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo, cobrado semestralmente durante o prazo original de

desembolsos, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos

Moeda de referência: A moeda na qual se pretende contratar o empréstimo ora pretendido é o dólar americano, considerando a cotação do câmbio de fechamento de venda, em 24/04/2023, de R$/US$ 5,05 ($ 1,00=R$ 5,05), conforme informação do BACEN.

Obs: Os valores das taxas de juros do BID são de referência, podendo variar conforme o período.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

A decisão de buscar financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) decorre principalmente do reconhecimento da expertise do Banco em financiar grandes projetos com finalidades similares, tanto no Brasil quanto nos demais países membros. Na atualidade, o BID é a principal fonte de financiamento multilateral para o desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe, e para a integração regional. Na área de políticas integradas de saúde, o BID financia atualmente a execução de 50 projetos em toda América Latina e Caribe.

Além disso, o Governo paulistano compartilha do entendimento do BID de que as ações de cooperação técnica, consultoria, financiamentos, assistência técnica e pesquisas devem ser realizadas de forma sustentável. Considera, ainda, que essas ações estão relacionadas a um amplo leque de possibilidades que, se integradas, potencializam o alcance dos objetivos propostos. Portanto, o valor agregado pelo Banco, além da contribuição financeira, em todas as fases dos programas ou projetos, inclui também ênfase nas ações de sustentabilidade institucional. O fortalecimento da qualidade da Gestão constitui, certamente, um dos objetos de preocupação e estratégias do BID, o que reforça a escolha da fonte externa de financiamento pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Somado a isso, comparativamente ao mercado interno, as condições oferecidas pelo BID mostram-se atrativas, especialmente quanto às taxas de juros.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

AREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

Em termos de sustentabilidade vale destacar que a requalificação dos hospitais, irá promover eficiência energética, redução de custos e sustentabilidades para os hospitais beneficiados. Em consonância com o Manual de Sustentabilidade para Edificações Públicas, da Secretaria Municipal de Serviços e Obras do Município de São Paulo (Anexo 05) que define as diretrizes e os parâmetros sustentáveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

O objetivo do Programa é contribuir para a melhorar as condições de saúde da população do Município de São Paulo, por meio da ampliação do acesso, da qualidade dos serviços ofertados, da garantia de segurança do paciente e da melhoria do desempenho dos processos da rede hospitalar municipal.

As populações de baixa renda e vulneráveis são as mais carentes de atendimento de Saúde, portanto, as intervenções propostas, ao melhorarem/ampliarem a oferta dos serviços hospitalares, irão atender majoritariamente este Público.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadão

A certificação de qualidade implicará em melhoria da prestação/processos dos serviços ofertados nos Hospitais, garantindo maior segurança para pacientes e profissionais de saúde tornando os processos de trabalho mais eficientes com melhor integração entre setores . Além dessa ação, cabe mencionar a inovação pretendida ao instalar um sistema informatizado de gestão de suprimentos intra-hospitalar.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde

Todas as ações do programa visam a melhoria das condições de Saúde da População por meio do aprimoramento do atendimento Hospitalar:

- requalificação/reforma dos hospitais;

- certificação de qualidade dos hospitais e dos laboratórios municipais;

- sistema informatizado de logística intra-hospitalar; e

- capacitação de profissionais da Saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

O sistema informatizado de gestão de suprimentos intra-hospitalar deverá gerar padronização e ganho de eficiência no fluxo de distribuição de insumos no hospital, redução de custos e aumento da segurança do paciente, inovando o processo de prescrição, dispensação e administração de Medicamentos.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Está prevista no Programa a realização de PPP para a requalificação de três Hospitais.

BENEFICIÁRIOS

Os beneficiários últimos das ações propostas nesta Carta Consulta são todos os cidadãos do município de São Paulo, ou seja, mais de 12 milhões de habitantes.

Além dos munícipes paulistanos, São Paulo é referencia para outros 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo constituindo a quarta maior aglomeração urbana do mundo, com população de mais de 21 milhões de habitantes, além dos pacientes de outros Estados da Federação que na dificuldade de acesso, buscam alternativas na capital paulista.

Importante destacar que a cidade de São Paulo é pioneira ao instituir, através da lei municipal a "Política Municipal para a População Imigrante", a qual garante ao imigrante o pleno acesso a direitos sociais e serviços públicos "independentemente de sua situação imigratória e documental", não fazendo distinção entre brasileiros e imigrantes, assim como prevê a promoção da transparência sobre os dados de atendimento a essa população. Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, mais de 360 mil imigrantes vivem legalmente no município.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	160.000.000,00	1,00	160.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	250.600.000,00	1,00	250.600.000,00
Total:			410.600.000,00		410.600.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

O projeto será realizado pelo Município de São Paulo, através de sua Secretaria Municipal da Saúde (SMS-SP).

A secretaria formalizará, uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP), que servirá como órgão de ligação entre a SMS-SP, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outras organizações participantes.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Anexo 6

ARRANJO OPERACIONAL

O arranjo operacional deste programa contará com a equipe da SMS-SP com experiência prévia na execução de projetos com organismos internacionais, como foi o caso recente do Avança Saúde I.

Uma UGP está prevista, onde uma equipe de apoio adicional a equipe da SMS-SP será contratada para auxiliar no planejamento, execução e monitoramento do Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria Municipal da Saúde - Prefeitura do Município de São Paulo		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	**299.280.000,00**	**20.000.000,00**	**20.500.000,00**		
P - 1.1 Requalificação dos Hospitais	214.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais	60.000.000,00	0,00	0,00		
P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados	19.280.000,00	0,00	0,00		
P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras	6.000.000,00	0,00	500.000,00		
C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO	**102.820.000,00**	**0,00**	**2.220.000,00**		
P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar	3.000.000,00	0,00	500.000,00		

P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar	98.220.000,00	0,00	1.720.000,00		
P - 2.3 Certificação da Qualidade	800.000,00	0,00	0,00		
P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar	600.000,00	0,00	0,00		
P - 2.5 Capacitação	200.000,00	0,00	0,00		
C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	**8.500.000,00**	**0,00**	**560.000,00**		
P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento	6.000.000,00	0,00	400.000,00		
P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa	1.600.000,00	0,00	160.000,00		
P - 3.3 Consultoria de Comunicação	300.000,00	0,00	0,00		
P - 3.4 Avaliação do Programa	600.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**20.000.000,00**	**23.280.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR		**29.575.000,00**	**31.500.000,00**		
P - 1.1 Requalificação dos Hospitais		27.295.000,00	30.000.000,00		
P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais		0,00	0,00		
P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados		2.280.000,00	0,00		
P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras		0,00	1.500.000,00		
C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO		**100.000,00**	**21.600.000,00**		
P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar		0,00	1.500.000,00		
P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar		0,00	20.000.000,00		
P - 2.3 Certificação da Qualidade		0,00	0,00		
P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar		100.000,00	100.000,00		
P - 2.5 Capacitação		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**325.000,00**	**1.565.000,00**		
P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento		0,00	1.400.000,00		
P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa		260.000,00	100.000,00		
P - 3.3 Consultoria de Comunicação		25.000,00	25.000,00		
P - 3.4 Avaliação do Programa		40.000,00	40.000,00		
Total	**0,00**	**30.000.000,00**	**54.665.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR		**39.510.000,00**	**37.000.000,00**		
P - 1.1 Requalificação dos Hospitais		31.205.000,00	35.000.000,00		
P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais		0,00	0,00		
P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados		8.305.000,00	0,00		
P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras		0,00	2.000.000,00		
C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO		**195.000,00**	**26.695.000,00**		
P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar		0,00	1.000.000,00		
P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar		0,00	25.500.000,00		
P - 2.3 Certificação da Qualidade		100.000,00	100.000,00		
P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar		70.000,00	70.000,00		
P - 2.5 Capacitação		25.000,00	25.000,00		
C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**295.000,00**	**1.695.000,00**		
P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento		0,00	1.400.000,00		
P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa		180.000,00	180.000,00		
P - 3.3 Consultoria de Comunicação		25.000,00	25.000,00		
P - 3.4 Avaliação do Programa		90.000,00	90.000,00		
Total	**0,00**	**40.000.000,00**	**65.390.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR		**39.485.000,00**	**31.500.000,00**		
P - 1.1 Requalificação dos Hospitais		0,00	30.000.000,00		
P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais		37.000.000,00	0,00		
P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados		2.485.000,00	0,00		
P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras		0,00	1.500.000,00		
C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO		**270.000,00**	**25.770.000,00**		
P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar		0,00	0,00		
P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar		0,00	25.500.000,00		
P - 2.3 Certificação da Qualidade		150.000,00	150.000,00		
P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar		70.000,00	70.000,00		
P - 2.5 Capacitação		50.000,00	50.000,00		
C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**245.000,00**	**1.645.000,00**		

P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento		0,00	1.400.000,00		
P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa		180.000,00	180.000,00		
P - 3.3 Consultoria de Comunicação		25.000,00	25.000,00		
P - 3.4 Avaliação do Programa		40.000,00	40.000,00		
Total	**0,00**	**40.000.000,00**	**58.915.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR		**29.210.000,00**	**21.000.000,00**	**157.780.000,00**	**141.500.000,00**
P - 1.1 Requalificação dos Hospitais		0,00	20.500.000,00	78.500.000,00	135.500.000,00
P - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais		23.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
P - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados		6.210.000,00	0,00	19.280.000,00	0,00
P - 1.4 Apoio técnico à realização das obras		0,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00
C - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO		**235.000,00**	**25.735.000,00**	**800.000,00**	**102.020.000,00**
P - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
P - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar		0,00	25.500.000,00	0,00	98.220.000,00
P - 2.3 Certificação da Qualidade		150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
P - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar		60.000,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00
P - 2.5 Capacitação		25.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00
C - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**555.000,00**	**1.615.000,00**	**1.420.000,00**	**7.080.000,00**
P - 3.1 Apoio ao Gerenciamento		170.000,00	1.230.000,00	170.000,00	5.830.000,00
P - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa		180.000,00	180.000,00	800.000,00	800.000,00
P - 3.3 Consultoria de Comunicação		75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
P - 3.4 Avaliação do Programa		130.000,00	130.000,00	300.000,00	300.000,00
Total	**410.600.000,00**	**30.000.000,00**	**48.350.000,00**	**160.000.000,00**	**250.600.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para que seja iniciada a implementação do Programa, deverá ser elaborada e submetidos à Assembleia Legislativa Lei autorizativa para obtenção de empréstimo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Para implementação do Programa será contratado na modalidade consultoria profissionais para apoio ao gerenciamento, que atuará em parceria com a equipe da UGP, composta por funcionários da SMS-SP.

O custeio e manutenção dos serviços com a requalificação dos hospitais são viabilizados através de financiamento tripartite, principalmente via Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os possíveis impactos ambientais decorrentes que este Programa possa vir a apresentar serão minimizados através de projetos, ações e mecanismos voltados para a proteção do meio ambiente, para a redução ou para a mitigação de impactos ambientais que poderão ocorrer durante as intervenções, em conformidade com as leis municipais.

Além das leis ambientais as reformas seguirão o Manual de Sustentabilidade para Edificações Públicas, da Secretaria Municipal de Serviços e Obras, responsável pela implantação das obras do Programa Avança Saúde - SP. O manual detalha as diretrizes e os parâmetros sustentáveis que serão referencia para os novos projetos de edifícios municipais, para os quais destacamos: aquecimento de água com aproveitamento de energia solar, reaproveitamento de águas pluviais, dispositivos hidráulicos com sistemas econômicos, madeira certificada, destinação dos resíduos da obra e avaliação das posturas de uso e ocupação do solo, adoção de painéis solares fotovoltaicos.

A aplicação da legislação ambiental pertinente visa assegurar que os investimentos sejam ambientalmente e socialmente sustentáveis, e que, dessa forma, possam contribuir para atingir os objetivos do Programa e assim, os níveis esperados de eficácia, eficiência e efetividade dos projetos financiados.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não existe um impacto social do Programa que possa interferir negativamente na saúde da população do município, muito menos em populações vulneráveis como populações indígenas, quilombolas, entre outras.

O impacto social é positivo, na medida que qualifica a oferta de atendimento mais próximo das pessoas, além de gerar, durante a implementação oportunidades de emprego e renda.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN